

Repercussões sistêmicas do hipoestrogenismo

Tópicos 3, 4 e 5

Repercussões sistêmicas do hipoestrogenismo — Tópicos 3, 4 e 5

Material-fonte para apresentação de seminário (climatério e menopausa). Estrutura: 15 slides, 5 por tópico. Cada slide tem o conteúdo da tela e a fala sugerida. No fim de cada tópico há perguntas que a banca pode fazer, com respostas.

Ideia central (repetir ao longo da apresentação): o hipoestrogenismo tem repercussões reais e mensuráveis no coração, na mente e na sexualidade, mas o desfecho depende de genética, hábitos, contexto social e acesso ao cuidado. O hormônio pesa, mas nunca decide sozinho.

TÓPICO 3 — Risco cardiovascular e metabolismo lipídico (transição e cuidado preventivo)

Slide 3.1 — O risco cardiovascular da mulher tem várias causas

Tópico estruturante: o risco cardiovascular é multifatorial.

Conteúdo: - A doença cardiovascular (DCV) é a principal causa de morte em mulheres no Brasil e no mundo, à frente de todos os cânceres somados. - Até a menopausa, a mulher costuma ter menos eventos que o homem da mesma idade. Depois, essa diferença diminui de forma progressiva. - O hipoestrogenismo pesa, mas não decide sozinho. Determinantes: - Não modificáveis: idade, genética, história familiar de DCV precoce (parente de 1º grau homem com menos de 55 anos ou mulher com menos de 65), etnia. - Modificáveis: hipertensão arterial, diabetes, dislipidemia, tabagismo, sedentarismo, obesidade (sobretudo a central), alimentação e sono. - Psicossociais e estruturais: estresse crônico, depressão, baixa renda e escolaridade, racismo estrutural, insegurança alimentar, dificuldade de acesso ao serviço de saúde. - Específicos da mulher: menopausa precoce (antes dos 45 anos) e insuficiência ovariana prematura (antes dos 40), pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, SOP, doenças autoimunes (LES, artrite reumatoide). - A DCV na mulher ainda é subdiagnosticada e subtratada: os sintomas de síndrome coronariana costumam ser menos típicos (dispneia, fadiga, náusea, dor epigástrica), e tanto o profissional quanto a paciente percebem menos o risco.

Fala sugerida: “O ponto de partida é que a menopausa não ‘causa’ infarto. Ela entra numa rede de fatores que se somam. Para a mesma queda de estrogênio, a mulher tabagista, hipertensa e sedentária tem um risco completamente diferente da mulher ativa, normotensa e com boa rede de apoio. Explicar o risco só pelo hormônio leva a erros de prevenção.”

Slide 3.2 — A transição menopausal muda lipídios, gordura corporal e vasos

Tópico estruturante: o metabolismo lipídico pode se modificar.

O que o estrogênio faz no sistema cardiovascular: - Vasodilatação pela via do receptor $ER\alpha$, que ativa a eNOS e aumenta o óxido nítrico. - Ação anti-inflamatória e antioxidante, com menor expressão de moléculas de adesão (VCAM-1, ICAM-1). - No fígado, aumenta os receptores de LDL, o que eleva a depuração do LDL-c. - Favorece a gordura de padrão subcutâneo, glúteo-femoral (ginoide).

O que muda no hipoestrogenismo: - Lipídios: o estudo SWAN mostrou aumento de LDL-c e ApoB de cerca de 10 a 15% concentrado em torno da última menstruação, independentemente do envelhecimento. Os triglicerídeos sobem. A Lp(a) pode aumentar. O HDL-c pode até subir em número, mas perde funcionalidade (menor efluxo de colesterol), o que torna o “HDL alto” menos protetor. - Composição corporal: a gordura se redistribui para o abdome (padrão androide, visceral) e a massa magra diminui (sarcopenia), mesmo com peso estável. - Metabolismo glicídico: aumenta a resistência à insulina e o risco de síndrome metabólica. - Vasos: surgem disfunção endotelial, aumento da rigidez arterial e da pressão arterial, e progressão da espessura médio-intimal da carótida.

Fala sugerida: “O SWAN, coorte longitudinal multiétnica, mostrou que a alteração lipídica se concentra no ano em torno da menopausa, o que sugere um efeito próprio da transição e não só da idade. Mesmo assim, esse perfil é um risco que se modifica com intervenção, e não um destino.”

Slide 3.3 — Sedentarismo e tabagismo, os fatores mais modificáveis

Tópico estruturante: sedentarismo e tabagismo aumentam o risco.

Tabagismo: - Causa lesão endotelial, estado pró-trombótico, oxidação do LDL e redução do HDL. - Tem efeito antiestrogênico: acelera o metabolismo hepático do estradiol e é tóxico para os folículos. Por isso antecipa a menopausa em 1 a 2 anos e intensifica os fogachos. - O risco relativo de infarto associado ao tabagismo é proporcionalmente maior na mulher que no homem. - Parar de fumar reduz de forma importante o risco coronariano já nos primeiros anos.

Sedentarismo: - Piora a resistência à insulina, o acúmulo de gordura visceral, a pressão arterial e o perfil lipídico, e acelera a perda muscular e óssea. - Recomendação (OMS): 150 a 300 minutos por semana de atividade aeróbica moderada, ou 75 a 150 minutos de atividade vigorosa, mais exercício de força em 2 ou mais dias por semana. A força é fundamental no climatério, para músculo, osso e glicemia. - Reduzir o tempo sentado também conta.

Fatores que se somam: alimentação ultraprocessada, consumo de álcool, sono curto ou de má qualidade e estresse crônico.

Fala sugerida: “O tabagismo é o exemplo mais claro de como o comportamento e o hormônio se cruzam. O cigarro reduz o estrogênio, antecipa a menopausa e ainda lesa diretamente o endotélio. Ou seja, um fator modificável agrava o próprio hipoestrogenismo.”

Slide 3.4 — A prevenção começa antes da menopausa

Tópico estruturante: a prevenção deve começar precocemente.

- A aterosclerose é um processo de décadas. O que se faz na vida reprodutiva e na perimenopausa define o risco aos 60 ou 70 anos.

- Valorizar a história ginecológica e obstétrica como marcador de risco: pré-eclâmpsia, hipertensão gestacional, diabetes gestacional, parto prematuro, SOP e menopausa precoce ou IOP são potencializadores de risco reconhecidos pelas diretrizes.
- Estratificar o risco:
 - Usar escores validados: o Escore de Risco Global da SBC e as equações PREVENT da AHA (2023).
 - Ajustar a estratificação pelos potencializadores de risco específicos da mulher.
 - Pedir os exames iniciais: perfil lipídico, glicemia ou HbA1c, função renal, aferição correta da PA, circunferência abdominal e IMC.
- Terapia hormonal da menopausa (THM) — o que a banca vai perguntar:
 - A THM não está indicada para prevenção cardiovascular, nem primária nem secundária. Sua indicação é o tratamento de sintomas, sobretudo os vasomotores.
 - Hipótese da janela de oportunidade: o WHI incluiu mulheres em média com 63 anos e mostrou aumento de eventos. Estudos e reanálises em mulheres com menos de 60 anos ou com menos de 10 anos de menopausa (ELITE, KEEPSP, subanálises do WHI) mostraram perfil neutro ou favorável.
 - Contraindicações cardiovasculares: doença coronariana estabelecida, AVC, tromboembolismo venoso prévio. Se houver indicação, a via transdérmica tem menor risco trombótico.

Fala sugerida: “A gestação funciona como um ‘teste de estresse’ cardiovascular natural. A mulher que teve pré-eclâmpsia aos 30 anos precisa ser lembrada aos 45. E a pergunta clássica da banca: THM previne infarto? Não. A indicação é sintomática, e a decisão é individualizada, levando em conta idade, tempo de menopausa e risco basal.”

Slide 3.5 — O climatério como oportunidade de promover saúde

Tópico estruturante: o climatério é oportunidade de promoção da saúde.

- Nessa fase, a mulher procura o serviço por causa dos sintomas, e esse contato é o momento de abordar a saúde cardiovascular.
- “Life’s Essential 8” (AHA) como roteiro prático: alimentação, atividade física, tabagismo, sono, peso, colesterol, glicemia e pressão arterial.
- Plano de cuidado:
 - Alimentação: padrão mediterrâneo ou DASH, menos ultraprocessados, sódio e açúcares, mais fibras, de acordo com o Guia Alimentar para a População Brasileira.
 - Atividade física: aeróbica e de força.
 - Cessação do tabagismo: abordagem breve, terapia cognitivo-comportamental e farmacoterapia pelo Programa Nacional de Controle do Tabagismo do SUS.
 - Controle dos fatores de risco: meta pressórica habitualmente abaixo de 130/80 mmHg em quem tem risco elevado; meta de LDL conforme o risco; estatina quando indicada.
 - Sono e saúde mental como componentes do risco cardiovascular.
- Cuidado longitudinal na Atenção Primária, com equipe multiprofissional (nutrição, educação física, psicologia) e Academia da Saúde.

- Educação em saúde e autonomia: decisão compartilhada, metas realistas e respeito ao contexto socioeconômico. Prescrever “academia” para quem não tem tempo nem renda é uma recomendação desconectada da vida real.

Fala sugerida: “Fecho o tópico 3 com a ideia de que o climatério não é só um período de risco, é uma oportunidade estratégica. A paciente que chega por causa do fogacho sai com a pressão aferida, o tabagismo abordado e um plano de atividade física possível dentro da realidade dela.”

Perguntas da banca — Tópico 3

1. Por que o HDL alto pode não proteger na pós-menopausa? Porque o HDL perde funcionalidade (capacidade de efluxo de colesterol e ação anti-inflamatória). O que protege é a função, não só a concentração.
2. Explique a janela de oportunidade. O efeito vascular do estrogênio depende de o endotélio ainda estar saudável. Quando já existe placa estabelecida, o estrogênio pode desestabilizá-la e favorecer a trombose.
3. Cite potencializadores de risco cardiovascular específicos da mulher. Pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, SOP, menopausa precoce ou IOP e doenças autoimunes.

TÓPICO 4 — Saúde mental, sono e sintomas subjetivos (escuta e validação)

Slide 4.1 — Sono e sintomas vasomotores

Tópico estruturante: o sono pode ser afetado por sintomas vasomotores.

- De 40 a 60% das mulheres na transição menopausal referem queixas de sono: dificuldade para iniciar o sono, despertares frequentes e sono não reparador.
- Fisiopatologia dos fogachos: a queda do estrogênio leva à hipertrofia dos neurônios KNDy (kisspeptina, neurocinina B, dinorfina) no hipotálamo. O sinal da neurocinina B pelo receptor NK3 fica exagerado, a zona termoneutra se estreita e surgem episódios de calor, sudorese e taquicardia.
- Os suores noturnos causam despertares, o sono se fragmenta, e vêm fadiga, irritabilidade e dificuldade de concentração no dia seguinte.
- Outras causas que não se pode deixar passar:
 - Apneia obstrutiva do sono: a prevalência aumenta após a menopausa, pela perda do efeito estimulante respiratório da progesterona e pela redistribuição de gordura. Muitas vezes se manifesta como insônia e fadiga, sem o ronco “clássico”. Rastrear com STOP-BANG.
 - Síndrome das pernas inquietas, noctúria (relacionada à SGM), dor crônica, depressão e ansiedade, medicamentos, álcool, cafeína e uso de telas.
- Abordagem: a TCC-I (terapia cognitivo-comportamental para insônia) é a primeira linha. Tratar os sintomas vasomotores quando indicado, com THM ou opções não hormonais (ISRS/IRSN em dose baixa, gabapentina, antagonistas de NK3 como fezolinetante e elinzanetante). Evitar o uso crônico de benzodiazepínicos.

Fala sugerida: “A insônia do climatério não é um diagnóstico único. Ela pode vir do fogacho, da apneia, da depressão ou da sobrecarga da vida. Por isso a anamnese do sono precisa ser detalhada antes de qualquer prescrição.”

Slide 4.2 — Queixas emocionais: acolher e reconhecer a janela de vulnerabilidade

Tópico estruturante: as queixas emocionais devem ser acolhidas.

- Janela de vulnerabilidade: na perimenopausa, o risco de sintomas depressivos é cerca de 2 a 4 vezes maior (SWAN e Penn Ovarian Aging Study), inclusive em mulheres sem história prévia de depressão.
- Mecanismos propostos:
 - A flutuação do estradiol, mais do que o nível baixo em si, interfere na neurotransmissão serotoninérgica, noradrenérgica e GABAérgica.
 - Hipótese do dominó: fogachos levam a insônia, que leva a sintomas depressivos.
 - Sensibilidade hormonal individual: mulheres com história de TDPM ou de depressão pós-parto têm maior risco.
- Queixas frequentes: irritabilidade, ansiedade, labilidade emocional, choro fácil, fadiga e anedonia.
- Queixas cognitivas (“névoa mental”): dificuldade de concentração e de memória verbal. Os dados do SWAN indicam que esse quadro tende a ser transitório, com recuperação na pós-menopausa. Ainda assim, um declínio progressivo exige investigação (afastar depressão, hipotireoidismo, deficiência de B12 e demência).
- Acolher significa reconhecer que o sintoma é real, sem minimizar (“é só a idade”) e sem dramatizar.

Fala sugerida: “Do ponto de vista biológico há, sim, uma janela de maior vulnerabilidade. Isso dá legitimidade à queixa da mulher. Validar não é concordar que tudo é hormonal, é reconhecer que o sofrimento existe e merece cuidado.”

Slide 4.3 — O sofrimento não se explica só por hormônios

Tópico estruturante: o sofrimento não deve ser reduzido a hormônios.

- O risco de duas reduções opostas:
 - Atribuir tudo à menopausa (“é hormonal”), o que leva a perder diagnósticos como depressão maior, transtorno bipolar, transtorno de ansiedade, violência doméstica e uso de álcool.
 - Descartar a menopausa (“é psicológico”), o que leva a deixar de tratar sintomas vasomotores que alimentam a insônia e o humor deprimido.
- Diagnósticos diferenciais obrigatórios: hipotireoidismo e hipertireoidismo, anemia, deficiência de B12 e vitamina D, apneia do sono, diabetes, efeitos adversos de medicamentos, luto e transtornos de humor primários.
- A THM não é antidepressivo. Há evidência de benefício no humor na perimenopausa com sintomas vasomotores, mas a depressão maior deve ser tratada como depressão maior, com psicoterapia e antidepressivo.
- Sinais de alerta que pedem encaminhamento ou manejo especializado: ideação suicida, sintomas psicóticos, prejuízo funcional grave, suspeita de bipolaridade, uso abusivo de substâncias.

- Estereótipos a evitar: a “mulher histérica” e a “louca da menopausa”. Esses estereótipos historicamente silenciaram queixas legítimas das mulheres.

Fala sugerida: “O raciocínio clínico correto é de soma, não de exclusão: o hormônio pode contribuir, e outros fatores também contribuem. O estudante precisa sair daqui sabendo pesquisar ideiação suicida numa consulta de climatério, porque isso salva vidas.”

Slide 4.4 — O contexto social e a saúde mental

Tópico estruturante: o contexto social influencia a saúde mental.

- O climatério coincide com uma fase de grandes demandas de vida:
 - A chamada “geração sanduíche”: cuidado com filhos e com pais idosos ao mesmo tempo.
 - Dupla ou tripla jornada (trabalho remunerado, doméstico e de cuidado).
 - Pressão no trabalho, risco de desemprego, aposentadoria.
 - Mudanças familiares: saída dos filhos de casa, divórcio, viuvez, luto.
 - Surgimento de doenças crônicas próprias ou na família.
- Determinantes sociais: renda, escolaridade, raça/cor e território. Mulheres negras e de baixa renda têm sintomas vasomotores mais intensos e prolongados (SWAN) e menos acesso a cuidado.
- Violência contra a mulher: pode ser a causa oculta de insônia, ansiedade e depressão. Perguntar ativamente e conhecer a rede de proteção.
- Fatores culturais: em culturas que valorizam a juventude, a menopausa pode ser vivida como perda. Em outras, como libertação. A forma como a mulher vive essa fase também é construída socialmente.
- Fatores de proteção: rede de apoio, vínculo com a equipe de saúde, participação social, atividade física e espiritualidade.

Fala sugerida: “Duas mulheres com o mesmo estradiol podem viver o climatério de formas opostas. Uma tem rede de apoio e autonomia financeira, a outra cuida sozinha da mãe com Alzheimer e trabalha em dois empregos. O contexto não é pano de fundo, ele faz parte do diagnóstico.”

Slide 4.5 — Escuta qualificada: do acolhimento ao plano de cuidado

Tópico estruturante: escuta qualificada é indispensável.

- Método Clínico Centrado na Pessoa (MCCP). Explorar a doença e a experiência de adoecer pelo SIFE:
 - Sentimentos: “Como a senhora tem se sentido?”
 - Ideias: “O que acha que está causando isso?”
 - Funcionalidade: “Como isso afeta seu dia a dia?”
 - Expectativas: “O que espera desta consulta?”
- Habilidades de comunicação: perguntas abertas, escuta sem interrupção precoce, empatia verbal (“Faz sentido a senhora estar cansada com tudo isso”), resumo e checagem.
- Instrumentos de apoio, que complementam a escuta e não a substituem:
 - PHQ-2 e PHQ-9 (depressão) e GAD-7 (ansiedade).
 - Escala de Kupperman ou MRS (Menopause Rating Scale) para os sintomas climatéricos.
 - ISI (Índice de Gravidade da Insônia) e STOP-BANG.

- Conduta escalonada:
 1. Acolher e explicar a fisiologia (educação em saúde reduz a ansiedade).
 2. Orientar hábitos: higiene do sono, atividade física, menos álcool e cafeína.
 3. Tratar os sintomas vasomotores quando indicado.
 4. Oferecer psicoterapia, grupos na APS e práticas integrativas (PICS).
 5. Usar farmacoterapia quando indicada.
 6. Encaminhar para a RAPS (CAPS ou psiquiatria) em casos graves.
- Cuidado longitudinal: retorno programado, vínculo e coordenação do cuidado.

Fala sugerida: “A escuta qualificada é uma competência técnica, não um ‘extra’ de gentileza. Ela aumenta a precisão diagnóstica, a adesão e a satisfação, e é o que impede que o sofrimento da mulher seja reduzido a um estereótipo.”

Perguntas da banca — Tópico 4

1. Qual a primeira linha para a insônia crônica? TCC-I.
2. Qual é o alvo dos novos fármacos não hormonais para fogachos? O receptor NK3 da neurocinina B no hipotálamo (fezolinetante, elinzanetante).
3. Toda depressão no climatério é hormonal? Não. A transição aumenta a vulnerabilidade, mas é preciso fazer o diagnóstico diferencial, avaliar o contexto e tratar a depressão maior segundo os critérios próprios dela.

TÓPICO 5 — Sexualidade e envelhecimento saudável (autonomia, prazer e qualidade de vida)

Slide 5.1 — A sexualidade continua importante no envelhecimento

Tópico estruturante: a sexualidade permanece relevante no envelhecimento.

- Conceito da OMS: a sexualidade é um aspecto central do ser humano ao longo de toda a vida. Envolve sexo, identidade, orientação, erotismo, prazer, intimidade e reprodução. Não se resume à relação genital nem à frequência de relações.
- Modelos de resposta sexual:
 - Masters e Johnson e Kaplan: modelo linear (desejo, excitação, orgasmo, resolução).
 - Basson (2000): modelo circular, especialmente aplicável a mulheres em relacionamentos longos e no climatério. A motivação pode partir da intimidade emocional, e o desejo pode ser responsivo (surge depois do estímulo, e não antes dele).
- Evidência: muitas mulheres continuam sexualmente ativas e satisfeitas após os 60 e 70 anos. Desejo menor não significa, por si só, disfunção.
- Disfunção sexual (DSM-5) exige sofrimento pessoal significativo e duração de pelo menos 6 meses. Sem sofrimento, não há doença a tratar.
- Mito a desconstruir: a “pessoa idosa assexuada”.

Fala sugerida: “O modelo de Basson muda a lógica da consulta. Uma mulher que diz ‘não sinto vontade espontânea, mas quando começa é bom’ não necessariamente tem disfunção. Ela pode estar descrevendo um desejo responsivo, que é absolutamente normal.”

Slide 5.2 — Síndrome geniturinária da menopausa (SGM)

Tópico estruturante: sintomas geniturinários podem interferir no conforto.

- Definição (ISSWSH/NAMS, 2014): conjunto de sinais e sintomas vulvovaginais e urinários causados pelo hipostrogenismo. O termo substituiu “atrofia vulvovaginal”.
- Afeta cerca de 50 a 70% das mulheres pós-menopausa. Ao contrário dos fogachos, é progressiva e não melhora espontaneamente, e é muito subnotificada (vergonha e falta de pergunta ativa).
- Fisiopatologia: a mucosa afina, a lubrificação e a elasticidade diminuem, os lactobacilos se reduzem, o pH vaginal sobe para mais de 4,5 e o fluxo sanguíneo cai.
- Sintomas:
 - Genitais: secura, ardor, prurido.
 - Sexuais: dispareunia, sangramento pós-coito, menos lubrificação.
 - Urinários: urgência, disúria, ITU de repetição.
- Ciclo da dor: dispareunia leva a antecipação da dor, que leva a menos excitação e lubrificação, mais dor, evitação e queda do desejo.
- Tratamento escalonado:
 - Lubrificantes (na relação) e hidratantes vaginais (uso regular).
 - Estrogênio vaginal em baixa dose, com absorção sistêmica mínima e boa segurança.
 - Prasterona (DHEA) vaginal e ospemifeno.
 - Fisioterapia pélvica.
 - Estímulo à atividade sexual, que ajuda a manter o trofismo.

Fala sugerida: “A SGM é o melhor exemplo de que uma queixa sexual pode ter base orgânica tratável, e é simples tratá-la. Mas se o médico não pergunta, a mulher sofre em silêncio, muitas vezes por anos.”

Slide 5.3 — Autoimagem, corpo e fatores que influenciam a vida sexual

Tópico estruturante: a autoimagem influencia a vida sexual.

- Mudanças no corpo: ganho de peso, gordura abdominal, mudanças na pele, nos cabelos e nas mamas. Sobre tudo em uma cultura que associa beleza e desejo à juventude, isso pode afetar a autoestima e a disposição para a intimidade.
- Fatores biopsicossociais que modulam a sexualidade:
 - Biológicos: hipostrogenismo, redução de androgênios com a idade, SGM, incontinência urinária, prolapso, doenças crônicas (diabetes, DCV, câncer de mama e mastectomia, depressão), dor crônica.
 - Medicamentos: ISRS e IRSN, betabloqueadores, diuréticos tiazídicos, antiandrogênicos, inibidores de aromatase, tamoxifeno, benzodiazepínicos.
 - Psicológicos: depressão, ansiedade, imagem corporal, história de abuso.

- Relacionais: qualidade do vínculo, comunicação, conflitos, saúde do parceiro (disfunção erétil, por exemplo), ausência de parceria.
- Socioculturais: religião, educação sexual recebida, tabus sobre a sexualidade da mulher mais velha.
- Intervenções: fortalecer a autoestima, praticar atividade física (melhora a imagem corporal e o humor), oferecer espaço para falar sobre o corpo e rever medicamentos.
- Testosterona: o Consenso Global de 2019 aceita apenas para o transtorno do desejo sexual hipoativo na pós-menopausa, após avaliação criteriosa. Não há formulação feminina aprovada no Brasil, e o uso estético ou “anabolizante” deve ser desencorajado.

Fala sugerida: “A sexualidade é biopsicossocial por excelência. Antes de pensar em hormônio, o médico precisa perguntar: quais remédios ela usa? Como está o relacionamento? Como ela se sente em relação ao próprio corpo?”

Slide 5.4 — Cuidado sem julgamento: como abordar a sexualidade na consulta

Tópico estruturante: o cuidado deve ser sem julgamento.

- Barreiras do profissional: desconforto, falta de tempo, falta de formação e pressupostos (idade, heteronormatividade, estado civil).
- Como iniciar a conversa (normalizar e pedir permissão):
 - “Muitas mulheres nessa fase notam mudanças na vida sexual. Posso perguntar como está isso para a senhora?”
 - Usar linguagem neutra (“parceria”) e não presumir orientação sexual nem relação monogâmica.
- Modelo PLISSIT (Annon, 1976):
 - Permissão: legitimar o tema.
 - LI, informação limitada: explicar as mudanças fisiológicas.
 - SS, sugestões específicas: lubrificante, mais tempo de preliminares, mudança de posição, tratamento da SGM.
 - IT, terapia intensiva: terapia sexual ou de casal, quando necessário.
- Prevenção de ISTs na mulher mais velha: a incidência de sífilis e HIV vem aumentando em pessoas com mais de 50 anos no Brasil. A falta de risco de gravidez e a mucosa mais frágil favorecem a exposição. Oferecer testagem rápida, preservativo e PEP/PrEP quando indicado.
- Diversidade: mulheres lésbicas, bissexuais e trans, sem parceria, viúvas, com deficiência. Cada trajetória é legítima, inclusive a opção de não ter vida sexual.
- Ética: confidencialidade, respeito à autonomia e atenção a sinais de violência sexual.

Fala sugerida: “Não julgar inclui não presumir: não presumir que ela é heterossexual, que tem marido, que não tem risco de IST porque tem 60 anos, ou que deveria querer ter relações. O papel do médico é abrir a porta, não empurrar a paciente por ela.”

Slide 5.5 — Envelhecimento saudável: autonomia, vínculo e qualidade de vida

Tópico estruturante: envelhecimento saudável envolve autonomia e vínculo.

- Conceito da OMS (Década do Envelhecimento Saudável, 2021–2030): envelhecimento saudável é desenvolver e manter a capacidade funcional que permite o bem-estar. Ele resulta da capacidade intrínseca (física e mental) em interação com o ambiente.
- Envelhecimento ativo (OMS, 2002) tem quatro pilares: saúde, participação, segurança e aprendizagem ao longo da vida.
- Integração com os tópicos anteriores:
 - Saúde cardiovascular e metabólica (tópico 3).
 - Saúde mental e sono (tópico 4).
 - Sexualidade e intimidade (tópico 5).
 - Saúde óssea e muscular (tópico 2).
 - Todos dependem de hábitos, vínculo e acesso ao cuidado.
- Componentes práticos: atividade física regular, alimentação adequada, prevenção de quedas, vacinação, rastreamentos adequados à idade, estímulo cognitivo, participação social e combate à solidão.
- Vínculo: relações afetivas, familiares e comunitárias, e o vínculo com a equipe de saúde (longitudinalidade da APS) como fator de proteção.
- Direitos: Estatuto da Pessoa Idosa e Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PNAISM). O cuidado deve preservar a autonomia e o protagonismo da mulher nas decisões sobre o próprio corpo.

Fala de encerramento: “Para concluir minha parte: o hipoestrogenismo tem repercussões reais e mensuráveis no coração, na mente e na sexualidade. Mas o desfecho depende de genética, hábitos, contexto social e acesso ao cuidado. Cabe ao médico unir fisiologia, prevenção, escuta qualificada e cuidado longitudinal, olhando a mulher no climatério não como ‘uma deficiência hormonal a corrigir’, mas como uma pessoa em transição, com direito a qualidade de vida, prazer e autonomia.”

Perguntas da banca — Tópico 5

1. Diferença entre os sintomas vasomotores e a SGM na evolução natural? Os vasomotores tendem a melhorar com os anos. A SGM é progressiva e não regride sem tratamento.
2. O estrogênio vaginal em baixa dose exige progestagênio para proteção endometrial? Em geral não, porque a absorção sistêmica é mínima.
3. O que é desejo responsivo? É o desejo que surge depois do estímulo e da intimidade (modelo de Basson). Não é disfunção.
4. Qual modelo orienta a abordagem sexual na consulta? O PLISSIT.

Referências para citar na banca

- Ministério da Saúde. Manual de Atenção à Mulher no Climatério/Menopausa. Brasília, 2008.
- FEBRASGO. Manual de Climatério, edição mais recente.
- The Menopause Society (antiga NAMS). Position Statement on Hormone Therapy (2022) e Nonhormone Therapy (2023).

- El Khoudary SR et al. Menopause Transition and Cardiovascular Disease Risk, AHA Scientific Statement. Circulation, 2020.
- Estudo SWAN (Study of Women's Health Across the Nation), publicações sobre lipídios, sono, humor e cognição.
- Diretrizes da SBC sobre dislipidemia e prevenção cardiovascular, e Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial (2025).
- Basson R. The female sexual response: a different model. J Sex Marital Ther, 2000.
- Portman DJ, Gass ML. Genitourinary syndrome of menopause. Menopause, 2014.
- OMS. Envelhecimento Ativo: uma política de saúde (2002) e Década do Envelhecimento Saudável 2021–2030.
- Stewart M et al. Medicina Centrada na Pessoa (MCCP).

O que a banca valoriza (dicas finais)

- Citar o estudo SWAN.
- Saber responder que a THM não previne doença cardiovascular.
- Mostrar uma visão multifatorial, sem reduzir tudo ao hormônio.